

Classe	Substances (les plus usuelles)	Indications	Contre- indications	Effets indésirables (les plus usuels)	Remarques
Antalgique non AINS	Paracétamol	Douleurs d'intensité faible à modérée	Insuffisance hépatique, alcoolodépendance (>60 g/j)	Allergie cutanée, hépatotoxicité dose-dépendante	Une revue systématique récente (Chou et al., Ann Intern Med. 2007;147:478-91) relève un bénéfice faible du paracétamol lors de douleurs lombaires aiguës et chroniques
AINS	Ibuprofène Diclofenac Kétorolac Célécoxib	Douleurs nociceptives d'intensité faible à modérée	Ulcère gastro-duodéal (sauf célécoxib), hémorragie active, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque sévère, asthme	Insuffisance rénale, rétention hydrosaline, HTA, ulcère gastro-duodéal, hémorragie digestive; urticaire; céphalées, toxidermie	Une méta-analyse (Roelofs PD, Cochrane Database Syst Rev. 2008 23;(1):CD000396) met en évidence une efficacité des AINS à court terme dans des lombalgies aiguës et chroniques sans sciatalgie. Aucun AINS ne semble être supérieur aux autres.
Opioides faibles	Codéine, tramadol, buprénorphine	Douleurs modérées à fortes ne répondant pas au paracétamol et AINS	Iléus, insuffisance respiratoire sévère, insuffisance rénale, insuffisance hépatique	Nausées, vomissements, constipation, vertiges, somnolence, dépression respiratoire dose dépendante, dépendance	Inefficacité si bloqueur CYP2D6 ou génotype métaboliseur lent et risque d'intoxication si génotype métaboliseur rapide
Opioides forts	Morphine	Douleurs fortes	Insuffisance rénale sévère, insuffisance respiratoire sévère	Nausées, vomissements, constipation, vertiges, somnolence, dépendance	La morphine reste l'opioïde fort de choix, le fentanyl, l'hydromorphone et l'oxycodone sont des alternatives. Certains syndromes douloureux chroniques (dont certaines lombalgies) sont peu sensibles aux opioides notamment ceux dont le mécanisme physiopathologique n'est pas clairement établi.
Anti-dépresseurs	Amitriptyline	Douleurs neuropathiques ou syndrome douloureux chronique	Epilepsie, syndrome extrapyramidal	Sécheresse buccale, constipation, troubles de l'accommodation, confusion, prostatisme, sédation, prise de poids, troubles cardiovasculaires (tachycardie, hypotension orthostatique, allongement du QT), abaissement seuil épileptogène	Les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs mixtes du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (venlafaxine, duloxétine, milnacipran) ont démontré leur efficacité dans des études cliniques réalisées chez les patients douloureux chroniques. Lors de lombalgies chroniques leur niveau d'efficacité est moindre que lors de fibromyalgie.
Anti-épileptiques	Gabapentine, Prégabaline	Douleurs neuropathiques	Insuffisance cardiaque sévère	Vertiges, somnolence, ataxie, confusion, diplopie, œdèmes	Recommandations européennes : Gabapentine et prégabaline : A Carbamazépine : A pour névralgie du trijumeau Topiramate, valproate, lamotrigine : C (Attal N. et al. Eur J Neurol 2006, 13: 1153)
Myorelaxants	Tizanidine	Contractures musculaires	Myasthénie grave, insuffisance hépatique	Hypotension, bradycardie, sédation, confusion, xérostomie, rétention urinaire	